



ARCHITECTURE PRODUIT - VERSION 1

Arbre de decision et scoring

Baby Next Time - moteur d orientation clinique et humaine

Objectif : transformer les reponses du questionnaire d entree en une orientation claire, priorisee et actionnable, sans jamais afficher un score brut a l utilisatrice.

Important - ce scoring est un outil produit et de coordination. Il ne remplace ni un diagnostic, ni une decision medicale, ni une evaluation d urgence.

CE QUE PRODUIT LE MOTEUR

- 1 orientation primaire : urgence, medical prioritaire, psy prioritaire, parcours complexe, parcours standard, preconception / grossesse suivante.
- des modules secondaires : partenaire, couple, groupe de parole, care manager, kit personnalise.
- un delai cible d activation et un professionnel labellise a mobiliser en premier.
- une timeline J0 -> J60 adaptee au stade du parcours.

PRINCIPES DE CONCEPTION

- hard stop avant tout : la securite somatique et psychique prime sur le reste.
- precedence simple : une orientation primaire, puis des modules secondaires cumulables.
- step up / step down : on augmente ou on diminue l intensite selon les besoins.
- coordination pluridisciplinaire : le score sert a aiguiller vers le bon pro, pas a etiqueter la personne.

Comment fonctionne le moteur

Le moteur repose sur 2 couches. D'abord, des critères hard stop qui interrompent le parcours standard et imposent une reorientation rapide. Ensuite, un scoring pondéré dans 5 domaines : médical, psychologique, complexité, couple/partenaire et projection.

Règle prioritaire : si B1, B2, B3, B4 ou B5 = oui, ou si un opérateur estime que la personne n'est pas en sécurité, la logique de score classique est suspendue.

HARD STOPS

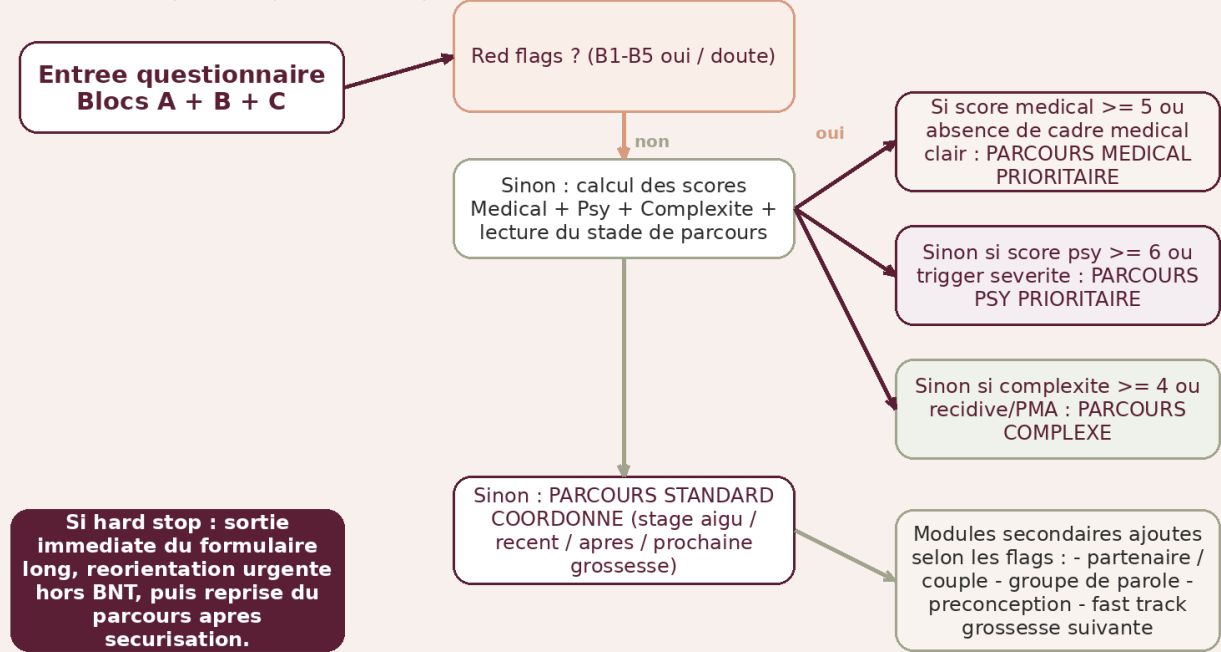
- saignements très abondants ;
- douleur abdominale intense, inhabituelle ou qui augmente ;
- malaise, vertiges importants, faiblesse marquée ;
- fièvre ou frissons ;
- grossesse extra-utérine évoquée, possible ou non exclue ;
- alerte psychique sévère identifiée par le pro ou l'équipe de coordination.

SORTIE HARD STOP

- orientation hors parcours digital long vers une évaluation médicale urgente ;
- message de sécurité concis ;
- reprise du parcours Baby Next Time seulement après sécurisation ;
- care manager en rappel de courtoisie si le contexte le permet.

Baby Next Time - arbre de decision v1

Lecture : hard stop d'abord, puis orientation primaire, puis modules secondaires.



Matrice de scoring - domaine medical

Score medical theorique : 0 a 12. En pratique, le seuil utile pour orienter en priorite medicale est fixe a 5.

DOMAINE 1 - CONTINUITE MEDICALE

Item	Question / signal	Points	Lecture
C1	Echographie deja realisee ?	non = 2 oui = 0	absence de cadrage diagnostique
C2	Explication claire donnee ?	partielle = 1 non = 2	besoin de clarification rapide
C3	Prise en charge proposee ?	aucune / ne sait pas = 2	absence de conduite a tenir
C4	Rendez-vous de controle prevu ?	non / ne sait pas = 2	risque de rupture de parcours
C5	Sentiment d etre informee ?	plutot non = 1 non = 2	besoin de re-explication
D2	Saignements actuels	importants = 1 tres importants = hard stop	majoration du suivi medical
D5	Epuisement physique	beaucoup = 1 enormement = 2	ajuste l intensite du check-in

Declenchement automatique medical prioritaire : score medical ≥ 5 , ou A3 = en cours de confirmation / non + absence d echographie, ou absence complete de cadre de prise en charge dans une phase aigue.

Matrice de scoring - domaine psychologique

Score psychologique theorique : 0 a 15. Seuil conseille pour une orientation psy prioritaire : 6. Trigger de severite si E2 presque tout le temps + E4 oui, meme si le total reste inferieur a 6.

DOMAINE 2 - DETRESSE PSYCHOLOGIQUE

Item	Question / signal	Points	Lecture
------	-------------------	--------	---------

E1	Etat emotionnel global	tres triste / anxieuse = 1 submergee = 2	nivele la detresse initiale
E2	Tout semble trop lourd	parfois = 1 souvent = 2 presque tout le temps = 3	mesure la charge globale
E3	Crises d angoisse / panique	parfois = 1 oui = 2	signe de fragilisation active
E4	Fonctionnement du quotidien	partiellement = 1 oui = 2	retentissement clinique utile
E5	Sentiment de solitude	beaucoup = 1 totalement = 2	indique isolement
E6	Culpabilite	beaucoup = 1 enormement = 2	cible les contenus et le suivi
E8	Souhait de parler a un psychologue	peut-etre = 1 oui = 2	ouvre l orientation volontaire

Matrice de scoring - complexite, couple et projection

Le domaine complexite sert surtout a activer une filiere renforcee. Le seuil recommande est 4.

DOMAINE 3 - COMPLEXITE / RECIDIVE

Item	Question / signal	Points	Lecture
G1	Premiere fausse couche ?	non = 1	sort du cas simple
G2	Nombre de pertes	1 = 1 2 = 3 3+ = 4	fait monter la complexite
G3	PMA en cours / recente	oui = 2	besoin de coordination specifique
G4	Antecedents medicaux / gyneco inquiets	oui = 1 ne sait pas = 1	ouvre la consultation specialisee
G5	Pas de suivi specialise actuel	non suivie = 1	risque de flottement
G6	Vulnerabilite psychique anterieure	oui = 2	augmente le niveau de vigilance

DOMAINE 4 - COUPLE / PARTENAIRE

Item	Question / signal	Points	Lecture
F1	Accompagnement actuel	non / c est complique = 1	declenche soutien relationnel
F3	Vecu tres different dans le couple	oui = 1	ouvre consultation a 2
F4	Tensions / silence / incomprehension	un peu = 1 oui = 2	module couple priorise
F5	Partenaire a besoin d aide	peut-etre = 1 oui = 2	module partenaire
F6	Souhaite un temps d echange a deux	peut-etre = 1 oui = 2	module couple actif

Le score couple n a pas vocation a devenir une orientation primaire seul. Il ajoute des modules :
entretien partenaire, consultation a 2, groupe de parole couple.

DOMAINE 5 - PROJECTION / PROCHAINE GROSSESSE

Item	Question / signal	Points	Lecture
H1	Souhaite retomber enceinte bientôt	oui = 1	ouvre preconception
H2	Prefere d abord recuperer	oui = 0	module de temporisation, pas de priorite
H3	Besoin d etre rassuree avant prochaine grossesse	peut-etre = 1 oui = 2	indique consultation preconception
H4	Souhaite un parcours prioritaire si nouvelle grossesse	oui = 1	active fast track

Regles d orientation et de precedence

Precedence recommandee : 1 urgence, 2 medical, 3 psy, 4 complexe, 5 standard. Les modules secondaires se cumulent au parcours primaire.

RÈGLES D ORIENTATION

Priorité	Déclencheur	Orientation primaire	Orientation secondaire / modules	Délai cible
Urgence	Hard stop somatique ou psychique	Evaluation urgente hors BNT / gyn eco / urgences selon contexte	care manager apres securisation ; kit ultra court ; reprise du parcours ensuite	immédiat
Medical prioritaire	Score medical >= 5 ou phase aigue sans cadre clair	BNT gynecologue- obstetricien referent ou BNT sage-femme de parcours	check-in care manager ; psy si score psy >= 3	24 h a 72 h
Psy prioritaire	Score psy >= 6 ou trigger severite	BNT psychologue perinatal	care manager ; partenaire ; psychiatre partenaire si fragilite severe	24 h a 72 h
Parcours complexe	Score complexite >= 4, recidive, PMA, contexte lourd	BNT consultation specialisee recidives / referent senior	psy ; preconception ; grossesse suivante fast track	7 j a 15 j
Standard coordonne	Aucun seuil haut atteint	BNT care manager + BNT sage-femme / premier recours	groupe de parole ; kit ; partenaire ; preconception selon H	sous 7 j

REGLES ADDITIONNELLES

- si score medical >= 5 et score psy >= 6 : orientation primaire medicale + rendez-vous psy declenche en parallele.
- si score complexe >= 4, le flag complexite reste actif meme si la personne entre d abord dans un parcours medical ou psy.
- si couple >= 3 : proposer systematiquement un espace partenaire ou un entretien a 2.
- si projection >= 2 : ajouter une consultation preconception ou reassurance, sauf si la personne veut explicitement temporiser.
- si A4 = nouvelle grossesse apres une perte : basculer vers le module fast track grossesse suivante, quel que soit le score projection.

Conseil produit : conserver la notion d orientation primaire + drapeaux secondaires. Eviter un systeme ou le score total unique deciderait de tout.

PROFESSIONNELS LABELLISES ET DELAIS

Qui intervient, et quand

- BNT premier recours : entree, triage, reassurance initiale, relais vers specialistes.
- BNT gynecologue-obstetrique referent : diagnostic, prise en charge, consultation de cloture, preconception medicale.
- BNT sage-femme de parcours : suivi de proximite, pedagogie, coordination douce, check-ins.
- BNT psychologue perinatal : detresse, culpabilite, peur de revivre cela, couple.
- BNT psychiatre partenaire : cas severes, antecedents psy, escalation clinique.
- BNT care manager : orchestration du parcours, rappels, reactivation, lien entre les pros.
- BNT animateur de groupe / pair-aidance supervisee : groupe de parole, sortie de l isolement.

PSEUDO-CODE SIMPLIFIE

- if hard_stop: route = URGENCE
- else compute medical_score, psy_score, complexity_score, couple_score, projection_score
- if medical_score >= 5 or acute_without_clear_plan: route = MEDICAL
- elif psy_score >= 6 or severe_psy_trigger: route = PSY
- elif complexity_score >= 4: route = COMPLEXE
- else: route = STANDARD
- then add secondary_flags(partner, couple, group, preconception, fast_track_next_pregnancy)

SOURCES DE CADRAGE

Le modele ci-dessus s appuie sur :

- France - loi du 7 juillet 2023 et orientations nationales DGOS du 26 juillet 2024 sur les parcours d interruption spontanee de grossesse.
- Ameli - reperes de prise en charge, signes d alerte, suites apres fausse couche et acces a Mon soutien psy.
- NICE - guideline sur ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management.
- ESHRE - guideline 2022 sur les pertes de grossesse recurrentes, incluant information, soutien et parcours de reassurance.

Version recommandee pour MVP : commencer par ces seuils, suivre les resultats reels, puis recalibrer apres 50 a 100 parcours. Ce document est un standard de depart, pas un protocole fige.